

GOLD T®

MINI — CU 375 MM² + AU

Bakırın etkisi, altın çekirdeğin dayanıklılığı.

Gold T® Mini — hormonsuz bakırlı rahim içi araç · 375mm² aktif bakır · 0,1mm altın çekirdek · en çok 5 yıl

Sistemik hormon içermez; adet siklusu ve doğal hormon dengesi korunur. Koruyucu etki yerleştirme anında başlar. Mini boy, 24mm genişliğiyle küçük uterus kavitesi için ölçeklendirilmiş seçenektir.

375mm² aktif bakır | %99,99 bakır saflığı | 0,1mm altın çekirdek | en çok 5 yıl
MINI 24 x 30,5mm | NORMAL 31 x 33mm | Ref. 01040200 | GTIN 8436021830173

EUROGINE, S.L. · Castelldefels, Barcelona · İspanya

CE 0318 · MDR Class III · etilen oksit ile steril · tek kullanımlık



Gold T® Mini nedir?

Hormonsuz bakırlı RİA — bakır telin merkezinde 0,1mm altın çekirdek, T/Y formunda esnek çerçeve.

375mm²

aktif bakır yüzey

%99,99

bakır saflığı

0,1mm

altın çekirdek çapı

5 yıl

en uzun kullanım süresi

Gold T® Mini, gebelikten korunmaya yönelik **hormonsuz** bir rahim içi araçtır. Baryum sülfat katkılı polietilen çerçevenin dikey gövdesi, aktif yüzeyi **375mm²** olan yüksek saflıkta (%99,99) bakır telle sarılmıştır. **Bu telin merkezinde 0,1mm çapında altın bir çekirdek bulunur.**

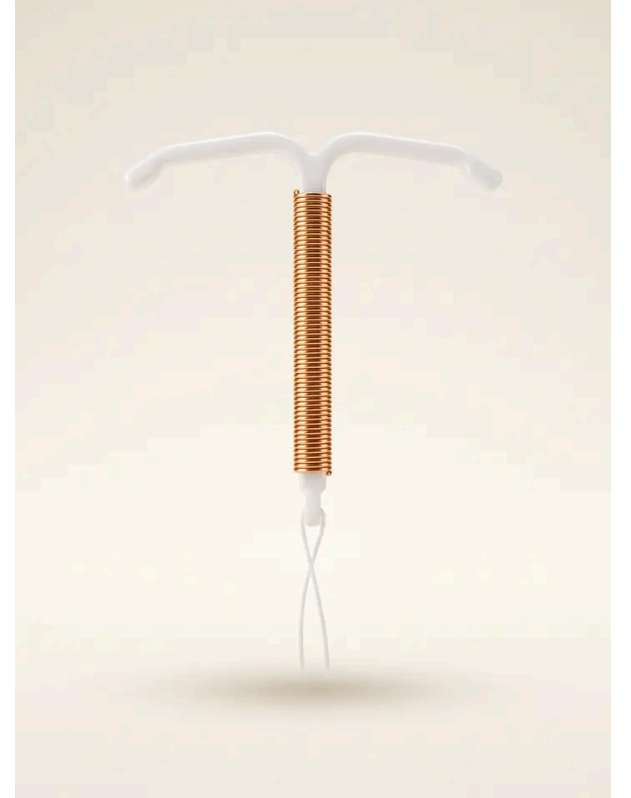
Altın, kontraseptif etkiye katkı vermez; üreticinin bildirdiği işlevi, bakır telin korozyona bağlı parçalanmaya karşı direncini artırmaktır. **Kontraseptif aktif yüzey yalnızca bakırdır.**

Kadın doğum uzmanı tarafından uterus kavitesine yerleştirilir ve koruyucu etkisini hemen gösterir; çıkarıldığında doğurganlık gecikmeden geri döner.

İKİ YÖNLÜ KORUYUCU ETKİ

- 1 Sperm:** salınan bakır iyonları spermin hareketliliğini ve yön bulmasını bozar; fertilizasyon büyük ölçüde gerçekleşmez — **primer etki fertilizasyon öncesidir.**
- 2 Endometrium:** bakır iyonlarının yarattığı lokal steril inflamatuvar ortam, döllenmiş bir yumurtanın implantasyonunu da engeller.

Etki mekanizması bakır iyonlarına bağlıdır ve hormonal değildir; ovulasyon baskılanmaz, adet siklusu devam eder.



T/Y formunda polietilen çerçeve · 375mm² bakır tel · altın çekirdek · çıkarma iplikleri — temsilî ürün görseli.

Teknik künye ve ürün kodları

Tedarik, ruhsat ve hasta dosyası için tek sayfalık referans.

CİHAZ KÜNYESİ

Üretici	EUROGINE, S.L. — Castelldefels, Barcelona / İspanya
Model	Gold T® Mini (Cu 375 + Au)
Üretici referansı	01040200
GTIN / EAN	8436021830173
PZN (Almanya)	14057156
Eski İspanyol C.N.	337793.5
Boyut (genişlik x uzunluk)	24 x 30,5mm
Aktif bakır yüzey	375mm ²
Bakır saflığı	%99,99
Altın çekirdek çapı	0,1mm
Bakır tel çapı / uzunluğu	0,4mm / 302mm (Rev. 11/2020 föy)
Çerçeve	Polietilen + baryum sülfat (radyopasite)
Çıkarma ipliği	Polietilen, 0,25mm x 450mm (2 adet)
İnserter kanülü	Polietilen, dış çap 3,8mm
İnserter gövdesi	ABS · histerometri skalası 5–10cm (0,5cm)
Sterilizasyon	Etilen oksit · tek kullanımlık
Kullanım süresi	En çok 5 yıl
Sınıf / işaret	MDR (AB) 2017/745 Class III · CE 0318

PORTFÖYDEKİ DİĞER BOYLAR

01040100 · Normal	31 x 33mm — güncel katalogda
01040000 · Maxi	36,5 x 38mm — eski föylerde; güncel 2026 kataloğunda yer almıyor

Her üç boyda da aktif bakır yüzey 375mm² olarak bildirilmiştir; boy lar kaviteye uyumu değiştirir, bakır yükünü değil.

Belge farkı — dikkat

Eurogine'in **Rev. 11/2020** teknik föyünde açıklama metninde **375mm²**, teknik tablo satırında ise **380mm²** yazmaktadır.

Üreticinin 2024–2026 tarihli güncel katalog ve hasta bilgilendirme belgeleri tutarlı biçimde **375mm²** bildirir. Bu broşürde ve hekim iletişimde **375mm²** esas alınmalıdır.

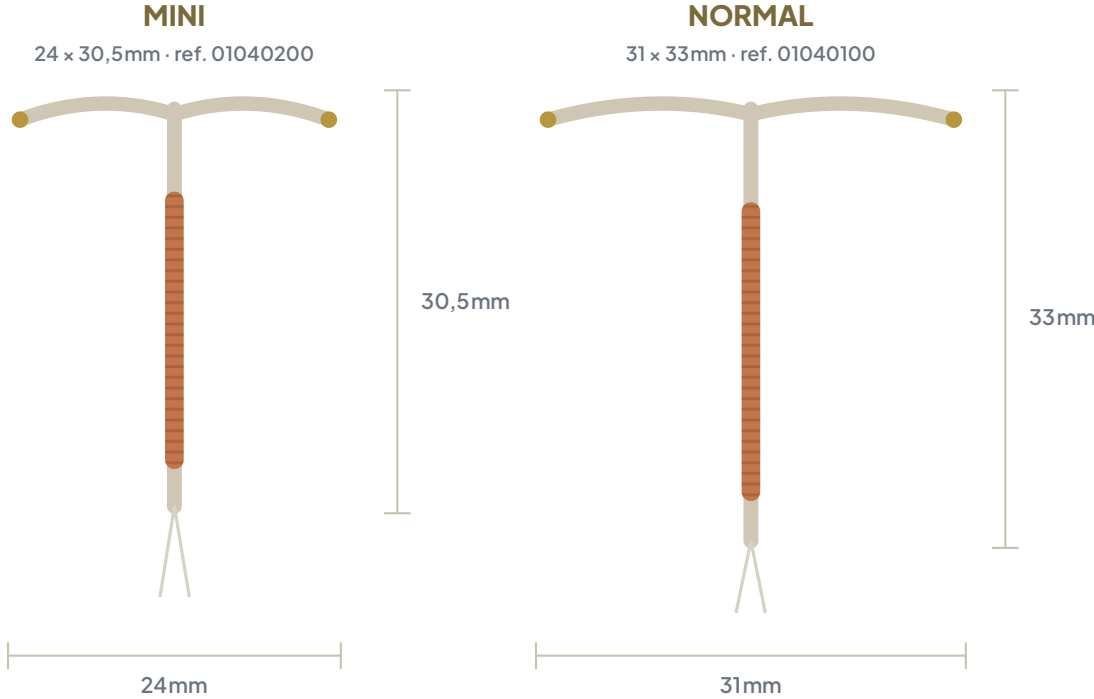
KUTU İÇERİĞİ VE ETİKETLEME

Steril tek kullanımlık blister ambalaj, önceden yüklenmemiş cihaz + inserter, çok dilli hasta bilgilendirme formu ve hasta kartı (yerleştirme ve kontrol tarihi).

MDR Madde 18 kapsamında Class III implante edilebilir cihazlarda hasta kartı (implant card) zorunludur; lot numarası hasta dosyasına kaydedilmelidir.

İki boy — karar histerometriye göre

MINI 24 x 30,5mm · NORMAL 31 x 33mm — her iki boyda da 375mm² bakır ve 0,1mm altın çekirdek.



Temsilî şema — ölçekli (5,2px/mm). Bakır sargı yalnızca dikey gövdededir; kollar bakır içermez.

BOY KARARI

- **MINI 24 x 30,5mm** — dar/küçük kavite, nullipar veya adölesan hastada tercih edilen boy.
- **NORMAL 31 x 33mm** — standart kavite genişliğinde.
- Karar, **başarılı histerometri** sonrasında verilir; cihaz inserter üzerindeki 5–10cm skala ile fundusa yerleştirilir.

IFU'dan doğrulayın

Üretici, Gold T için boy başına **sayısal kavite uzunluğu eşliği** yayımlamamaktadır. Eşik değer için ürünle gelen güncel IFU esas alınmalı; sınıf pratiğinde TCu380A tipi cihazlarda 6–9 cm sonda önerilir; 6 cm altındaki kavitede ekspulsiyon, kanama ve perforasyon sıklığı artar.

ETKİNLİK VE SÜRE

Üretici Gold T için ürüne özel bir Pearl indeksi yayımlamaz. Sınıf referansı olarak **EURAS-IUD** çalışmasında, 58.324 kişilik doğrulanmış RİA kohortu içindeki **bakırlı RİA kullanıcılarında** Pearl indeksi **0,52** (%95 GA 0,42–0,64) bildirilmiştir — hormonal uzun etkili yöntemlerle aynı güvenilirlik aralığı.

Kullanım süresi **en çok 5 yıl**; hekim tarafından her zaman çıkarılabilir, çıkarım sonrası doğurganlık gecikmez.

Not: Gold T'nin etiket süresi 5 yıldır; TCu380A'nın 10 yıllık etiketi bu ürün için geçerli değildir.

Heinemann K ve ark. Contraception. 2015;91(4):280–283. DOI: 10.1016/j.contraception.2015.01.011

Neden altın çekirdek?

Kontraseptif yüzey bakırdır. Altının tek görevi, o bakır telin beş yıl boyunca bütün kalmasıdır.

1 - Sorun: cihazın çalışması, telin aşınması demek

Bakırlı RİA'nın kontraseptif etkisi, bakırın uterus sıvısında çözünüp iyon salmasıyla ortaya çıkar. Yani **etki mekanizmasının kendisi bir korozyon sürecidir**. Tel beş yıl boyunca yüzeyinden aşınır, inceler ve lokal olarak kırılabilir.

Bakır telin ikincil fragmentasyonu — bütün görünen bir cihaz çıkarıldıktan sonra kavitede bakır parçası kalması — literatürde bildirilmiş bir komplikasyondur.

Dubovis M, Rizk N. Case Rep Womens Health. 2020;27:e00208. DOI: 10.1016/j.crwh.2020.e00208

2 - Çözüm: korozyona uğramayan bir çekirdek



0,4mm
bakır tel

0,1mm
altın çekirdek

Gerçek kesit —
temsilî makro görsel

KULLANIM SÜRESİ BOYUNCA



Bakır dıştan aşınır;
çekirdek kesintisiz kalır.

Zaman şeması temsildir; bakır telin dış çapı 0,4mm, altın çekirdek 0,1mm'dir.

SINIFTA EMSALİ OLAN BİR ÇÖZÜM

Bu yaklaşım Gold T'ye özgü değildir. Yaygın kullanılan **Nova-T 380**'de 0,4 mm bakır telin içinde **0,1 mm gümüş çekirdek** bulunur; üretici bu çekirdeğin işlevini **telin korozyona bağlı fragmentasyonunu önlemek ve cihazın ömrünü uzatmak** olarak tanımlar.

Gold T aynı mimariyi kullanır — 0,4 mm bakır tel, 0,1 mm çekirdek — **gümüş yerine altınla**.

ALTIN BU İŞ İÇİN NEDEN UYGUN?

- **Soy metal** — fizyolojik ortamda korozyona uğramaz.
- **Sünek** — 0,1 mm çapa çekilip bakırla sarılabilir.
- **Biyouyumlu** — implant ve dental kullanımda uzun geçmiş.
- **Mekanik süreklilik** — bakır aşınsa da tel boyunca kesintisiz omurga kalır.

Altın ne değildir — hasta ve hekim iletişiminde sınır

- Kontraseptif etkiye katkı vermez; aktif yüzey 375mm² bakırdır.
- Üretici altın için **antibakteriyel veya tedavi edici bir iddia bildirmez**.
- “Ayar” ve “altın halka” benzetmeleri bu ürüne uymaz: altın, tel içinde tek bir 0,1mm çekirdektir.

Yerleştirme sistemi

3,8mm kanül, ayarlanabilir flanş ve gövde üzerinde 5–10cm histerometri skalası.



İnserter ve ölçekli gövde — temsili görsel. Cihaz kullanım öncesinde hekim tarafından yüklenir.

SİSTEMİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- **Dış çapı 3,8mm** polietilen kanül.
- Gövde üzerinde **5–10cm** aralığında, 0,5cm bölmeli histerometri skalası.
- **Hareketli piston:** histerometri sonucuna ayarlanan flanş ile fundal yerleşimi hedefler.
- ABS gövde, tek kullanımlık, etilen oksit ile steril.
- İnserter tasarımı **ADI-FAD Delta Ödülleri 2013 seçkisinde** yer almıştır (tasarım: Enric Dachs Roig, Núria Coll Campmany).

ÜRETİCİ İDDİASI — OKUMA NOTU

Eurogine'in eski belgelerinde sistemin "başarılı histerometri sonrası perforasyonu tümüyle imkânsız kıldığı" ifadesi geçer. Üreticinin güncel belgelerinde bu ifade "**riski azaltır/en aza indirir**" biçiminde ölçülmüştür. Hekim iletişimde güncel, ölçülü ifade kullanılmalıdır.

NAZİK UYGULAMA — SAHADA

Bimanuel muayene > Spekulum > Antisepsi > Tenakulum > Histerometri > Flanşı ölçüye ayarla > No-touch yükleme > Fundusa yerleştir > İpliği 2–3cm bırak

Pelvik enfeksiyon riski esas olarak yerleştirmeyi izleyen ilk 20 güne sınırlıdır ve %1'in altındadır; rutin antibiyotik profilaksisi önerilmez. Ağır dismenore öyküsünde ağrı planı yerleştirme öncesinde konuşulmalıdır. Lot numarası hasta dosyasına ve hasta kartına kaydedilir.

Alternatif yöntemlere karşı

Aynı etkinlik sınıfı, tamamen farklı uygunluk profili — LNG-RİS, deri altı implant ve kombine hapla karşılaştırma.

	GOLD T® MİNİ · BAKIRLI RİA	LNG-RİS 52 MG	DERİ ALTI İMPLANT (ENG)	KOMBİNE HAP
Hormon	Yok	Levonorgestrel — lokal	Etonogestrel — sistemik	Östrojen + progestin — sistemik
Kullanım süresi	5 yıl	8 yıla kadar	3 yıl	Her gün
1. yıl başarısızlık (tipik kullanım)	~%0,8	~%0,1-0,4	~%0,05	~%7
Kullanıcı hatasına açık mı?	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
Uygulama	Kaviteye yerleştirme	Kaviteye yerleştirme	Kolda cilt altına minör girişim	Günlük ilaç
Adet paterni	Korunur (ilk aylarda artabilir)	~yarısında amenore / seyrek kanama	Öngörülemez; ~%20 amenore	Düzenli çekilme kanaması
Mevcut meme kanseri (US MEC 2024)	1 — kısıtlama yok	4	4	4
VTE öyküsü / auralı migren	1	2	2	4
Emzirme	Hormon geçişi yok	Uygun	Uygun	İlk haftalarda kısıtlı
En sık bırakma nedeni	Kanama/ağrı, ekspulsiyon	Amenore	Düzensiz kanama (~%11)	Uyum ve yan etki
Doğurganlığa dönüş	Çıkarımda hemen	Hızlı	Hızlı	Hızlı

US MEC kategorileri: 1 kısıtlama yok · 2 yarara göre ağır basar · 3 risk yarara göre ağır basar · 4 kabul edilemez risk. Başarısızlık oranları sınıf düzeyinde tipik kullanım değerleridir.

Hormonal yükün ölçülebilir karşılığı

LNG-RİS kullanımı meme kanseri ile **HR 1,4 (%95 GA 1,2-1,5)** ilişkili bulundu (78.595 eşleştirilmiş kullanıcı). Bakırlı RİA bu tartışmanın dışındadır.

Mørch LS ve ark. JAMA. 2024;332(18):1578-1580.

Adetin devamı bir tercih meselesi

20 randomize çalışmanın meta-analizinde amenore nedeniyle yöntemi bırakma, LNG-RİS'te bakırlı RİA'ya göre **RR 21,05 (8,83-50,00)** kat yüksekti.

Liu P ve ark. eClinicalMedicine. 2024;78:102926.

Aynı masada dürüst karşılaştırma

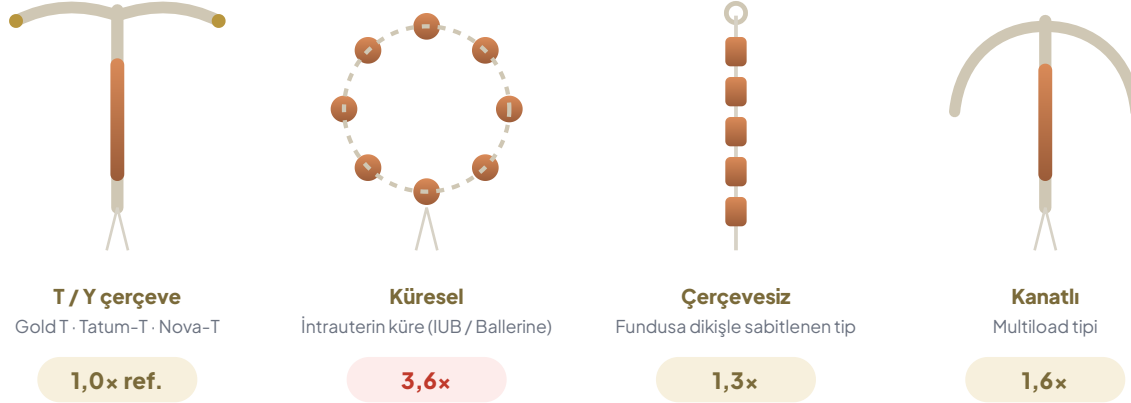
Üç yöntemi doğrudan karşılaştıran randomize çalışmada 1 yıllık devam: implant **%82,6**, LNG-RİS **%81,0**, TCu380A **%73,2**. Bırakma nedeni implantta kilo artışı, **bakırlı RİA'da ekspulsiyondur**.

Modesto W ve ark. Hum Reprod. 2014;29(7):1393-1399.

RİA'lar arasında nerede duruyor?

Şekil, genişlik ve bakır yükü — üç parametrenin üçünde de yayımlanmış karşılaştırmalı veri var.

Çerçeve şekline göre ekspulsiyon riski — düzeltilmiş HR, referans Tatum-T (Boehnke 2024; 26.381 kullanıcı)



Temsilî şemalar; marka görselleri değildir. Boehnke T ve ark. Contraception. 2024;140:110444. DOI: 10.1016/j.contraception.2024.110444

Bakır yükü: 375mm² hangi sınıfta?

35 randomize çalışma ve yaklaşık 48.000 kadını kapsayan Cochrane derlemesinde **TCu380A/TCu380S, MLCu375, MLCu250, TCu220 ve TCu200'den daha etkili** bulundu — etkinlik yüksek bakır yüküyle birlikte artıyor. Gold T'nin 375mm²'si bu yüksek yüklü sınıftadır.

Aynı derlemenin dürüst notu: hiçbir çerçeveli bakırlı cihazın nullipar kadınlar için diğerlerinden üstün olduğuna dair kanıt bulunamamıştır; bu grupta randomize veri azdır.

Kulier R ve ark. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(4):CD005347. DOI: 10.1002/14651858.CD005347.pub3

İntrauterin küre (Ballerine): veriler çelişkili

- Bağımsız prospektif çalışma:** 12 ayda ekspulsiyon **%27 (14/51)**, semptom nedeniyle çıkarım %16. Yazarlar cihazın mevcut tasarımıyla bakırlı RİA'lara **alternatif olarak kabul edilemez** olduğunu bildirdi.
- Üretici bağlantılı yazarların yer aldığı gerçek yaşam çalışmaları:** ekspulsiyon %3,4 (n=175) ve %5,3 (n=207).
- En büyük bağımsız kohort:** küresel tasarımda ekspulsiyon aHR **3,6 (2,7–4,9)**.

Okuma: küresel geometrinin ekspulsiyon üstünlüğü kanıtlanmamıştır; en geniş bağımsız veri seti aksi yöndedir.

Wiebe E, Trussell J. Contraception. 2015;93(4):364–366 · Baram I 2019 · Yaron M 2019 · Boehnke T 2024

GENİŞLİK VE ESNEKLİK

30 yaş altı 5.762 bakırlı RİA kullanıcısının analizinde **18–<30mm genişlik ve esnek kollar** daha yüksek devamla ilişkiliydi — Gold T Mini 24mm ve esnek kolludur.

Aynı analizde <300mm² bakır ve at nalı çerçeve de olumlu bulunmuştur; Gold T bu iki özelliğe uymaz. **Dört özelliğinden ikisi uyumludur** — ve düşük bakır yükü etkinliği düşürebileceğinden tek başına üstünlük sayılmaz.

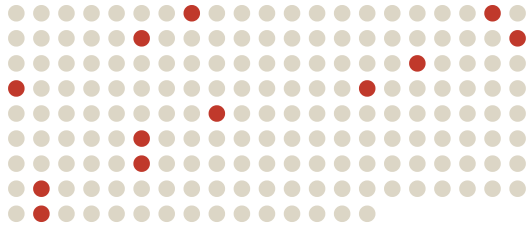
Akintomide H ve ark. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021;26(3):175–183.

Güvenlik profili — dosyaya girmesi gerekenler

Ürünün olumsuz verisi de bu broşürde yer alır: bir klinik yayın ve bir saha güvenlik bildirimi.

Spontan kırılma · Semiz & Özbay, 2025 · Medical Science Monitor

Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul · 2011–2021 · 463 kadın · retrospektif kohort



183 Gold T Normal kullanıcısı

■ 12 spontan kırılma

Karşılaştırma grubunda (n=280)
hiç kırılma görülmedi.

6,56%

Gold T® Normal (Cu 375 + Au) — 12/183 · %95 GA 2,97–10,15

0%

Flexi-T+ 300 (altın çekirdeksiz, Cu 300) — 0/280

9 / 12

kornuda — histeroskopi

3 / 12

servikal kanalda — Novak

%16,7

semptomsuz, rutin kontrolde

12–120 ay

kullanım süresi aralığı

ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI

Tek merkez, retrospektif; randomizasyon yok · yalnızca 2 cihaz modeli · kohort **en az bir vajinal doğum yapmış** kadınlarla sınırlı, **nullipar hasta dışlandı** — bulgular MINI'nin hedef grubuna doğrudan genellenemez · bir bölümü 5 yıllık etiket süresinin ötesinde kalmış cihazlar · mekanik dayanım testi yapılmadı, kırılma mekanizması hipotez düzeyinde.

Med Sci Monit. 2025;31:e950460. PMID 41275328. DOI: 10.12659/MSM.950460

2018–19 saha güvenlik bildirimi

Eurogine, Ancora, Novaplast ve **Gold T** ailelerini kapsayan bir bildirim yayımladı. Çerçeveyi oluşturan **polimer–baryum sülfat karışımının homojen dağılmaması** nedeniyle kolların kırılması mümkün oluyordu; kök neden hammadde tedarikçisinin üretim kusuruydu.

KAPSAM

01040000 · 01040100 · **01040200**
Lotlar: 0114 – 0917 arası tanımlı lotlar
2014 – Şubat 2018

OTORİTELER

AEMPS NI-PS 24/2019
BfArM 01783/18
FSRH CEU bildirisi, 2021

Bugün: bildirim tanımlı lotlarla sınırlıdır; piyasadaki Gold T Mini geri çağırılmış bir ürün değildir. Ancak o dönemde takılmış cihazlar hâlâ hastalarda olabilir.

Klinikte ne yapılmalı?

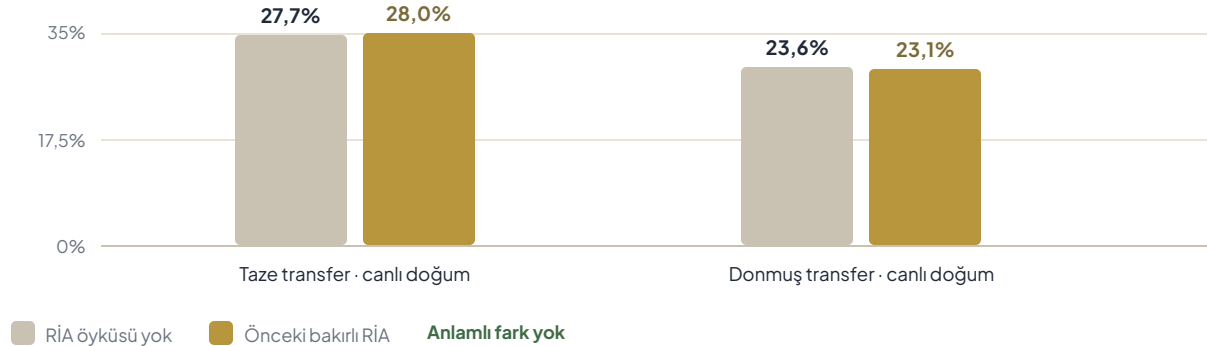
- Kırılma **semptomsuz** olabilir: yıllık ultrasonografik değerlendirme öner.
- Ara kanama veya açıklanamayan ağrıda **cihaz bütünlüğünü** görüntüle.
- Etiket süresini aşan kullanımdan kaçın; 5 yılda çıkar.
- 2014–2018 arası takılmış cihazda çıkarımı **kontrollü koşullarda** planla.
- Her yerleştirmede **lot numarasını** dosyaya ve hasta kartına yaz.

Her yaştan kadın için

IVF arası dönem, acil kontrasepsiyon, emzirme ve perimenopoz.



IVF/ICSI sonrası canlı doğum — önceki bakırlı RİA kullanımı (Huang 2026; 62.422 embriyo transfer siklusu)



Düzeltilmiş risk oranları: taze aRR 1,01 (%95 GA 0,91–1,11); donmuş aRR 0,97 (0,87–1,07). Önceki bakırlı RİA kullanımı IVF sonuçlarını etkilememiştir. **IVF planlanan hastada ara dönem kontrasepsiyonu; stimülasyon öncesi çıkarılır.**

Huang W ve ark. Front Cell Dev Biol. 2026;14:1790194. DOI: 10.3389/fcell.2026.1790194

Acil kontrasepsiyonda bakırlı RİA

Randomize çalışmada korunmasız ilişkiden sonraki 120 saat içinde bakırlı RİA takılan **321 hastanın hiçbirinde gebelik görülmedi** (%0; %95 GA 0–1,1) ve aynı uygulamayla 5 yıla kadar kalıcı koruma sağlandı.

IFU'dan doğrulayın Acil kontrasepsiyon, bakırlı RİA sınıfına ait bir uygulamadır; Gold T'nin onaylı endikasyonları için ürün IFU'su esas alınmalıdır.

Turok DK ve ark. N Engl J Med. 2021;384(4):335–344. · 2024 meta-analizinde bakırlı RİA, acil kontrasepsiyonda levonorgestrel içeren yöntemlerden daha etkili bulundu (OR 0,16; %95 GA 0,04–0,62; Gaio GS ve ark. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2024;305:153–158).

KİMLER İÇİN UYGUN?

- Kavitesi dar olan ve henüz doğum yapmamış kadınlar — **MINI**
- Yakın dönemde gebelik planlamayan veya aile planlamasını tamamlamış kadınlar
- Günlük/aylık uyum istemeyenler
- Meme kanseri, tromboz öyküsü veya ailesel yüksek risk; sigara, kilo, hipertansiyon nedeniyle hormonsuz korunması gerekenler
- Emzirmeyi sürdürmek isteyen anneler — doğum sonrası yerleştirme zamanı için IFU esas alınır
- Perimenopoz: adeti korur, hormon replasman tedavisine hormonal yük eklemeyiz

EUROGINE, S.L. — İspanya

Tasarım, üretim ve kalite kontrol tek tesiste; sterilizasyon sertifikalı dış kuruluşta.

ŞİRKET KÜNYESİ

Ünvan	EUROGINE, S.L. · NIF B59608919 · kuruluş 1991
Adres	C. Raurell 21–29, Nave 3 · 08860 Castelldefels, Barcelona
Tesis	Valide ve sertifikalı ISO Sınıf 7 temiz oda, üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarı, depolama
Sterilizasyon	Valide etilen oksit prosesi, sertifikalı dış kuruluş; lotlar akredite dış laboratuvarıda mikrobiyolojik kontrolden geçer
İhracat	50'den fazla ülke
İletişim	eurogine@eurogine.com · pedidos@ · worldwide@ · +34 93 630 43 45

BELGELER VE MEVZUAT

Kalite sistemi	UNE–EN ISO 13485:2018 / EN ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016
Sertifika no	2012 01 0006 EN
Kapsam	Tasarım, geliştirme ve aktif olmayan implantların üretimi
Geçerlilik	26 Kasım 2026 — yenilenme durumu tedarik öncesi teyit edilmeli
Cihaz mevzuatı	MDR (AB) 2017/745 · Class III · CE 0318
Ulusal izin	AEMPS ön sağlık lisansı (İspanya)
Class III, MDR'de en yüksek risk sınıfıdır; tasarım dosyası onaylı kuruluşça incelenir ve piyasaya arz sonrası izlem (PMS/PMCF) zorunludur.	

Sipariş kimliği — Gold T® Mini

Üretici referansı	GTIN / EAN	PZN	Eski C.N.
01040200	8436021830173	14057156	337793.5
24 x 30,5mm · 375mm ² · 1 adet steril ambalaj · en çok 5 yıl			

Türkiye — doğrulanması gereken alan

Eurogine uluslararası belgelerinde Türkiye'yi satış yapılan ülkeler arasında sayar ve **Medaks Sağlık** web sitesinde Eurogine rahim içi araçlarını ürün grubu olarak göstermeye devam eder.

Ancak bu sayfa **2017 tarihli**dir ve Gold T için **10 yıl** yazmaktadır; üreticinin güncel belgeleri **en çok 5 yıl** demektir. **Güncel distribütörlük yalnız bu sayfaya dayanarak kabul edilmemelidir.**

Doğrulama: TİTCK ÜTS kaydı · üreticiden yazılı teyit · Türkçe kılavuz.

Tedarik görüşmesi kontrol listesi

- Güncel CE 0318 sertifikası ve uygunluk beyanı
- Lot izlenebilirliği ve raf ömrü politikası
- ISO 13485'in güncel geçerlilik tarihi
- 2018–19 FSN sonrası düzeltici faaliyet raporu
- Türkiye ithalat/distribütörlük yetkisi
- PMS/PMCF özeti ve şikâyet kanalı

GOLD T® MINI

EUROGINE, S.L. · İSPANYA · CE 0318

HEKİME TEK CÜMLE

“Hormonsuz, 5 yıl, kullanıcı hatasına kapalı; 24mm MINI ile dar kavitede de uygulanabilir — hormonun kontrendike olduğu her hastada tam etkinlik.”

Broşürün dürüstlük notu: Bu dosyada üretici beyanları, sınıf düzeyindeki klinik kanıt ve ürünün olumsuz verisi ayrı ayrı işaretlenmiştir. Gold T® Mini'ye özgü randomize klinik çalışma bulunmamaktadır; karşılaştırma sayfalarındaki veriler sınıf düzeyindedir. Spontan kırılma verisi ve saha güvenlik bildirimi (s. 09) değerlendirmeye dâhil edilmelidir.

KAYNAKLAR

1. Semiz A, Özbay K. Med Sci Monit. 2025;31:e950460.
2. Heinemann K ve ark. Contraception. 2015;91(4):280–283.
3. Skovlund CW ve ark. JAMA Psychiatry. 2016;73(11):1154–1162.
4. Mørch LS ve ark. JAMA. 2024;332(18):1578–1580.
5. Liu P ve ark. eClinicalMedicine. 2024;78:102926.
6. Hubacher D ve ark. eClinicalMedicine. 2022;51:101554.
7. Akintomide H ve ark. BMJ Open. 2022;12(10):e060606.
8. Akintomide H ve ark. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021;26(3):175–183.
9. Boehnke T ve ark. Contraception. 2024;140:110444.
10. Kulier R ve ark. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(4):CD005347.
11. Wiebe E, Trussell J. Contraception. 2015;93(4):364–366.
12. Baram I ve ark. 2019;25(1):49–53 · Yaron M ve ark. 2019;24(4):288–293 (Eur J Contracept Reprod Health Care).
13. Modesto W ve ark. Hum Reprod. 2014;29(7):1393–1399.
14. Jensen JT ve ark. Am J Obstet Gynecol. 2022;227(6):873.e1–12.
15. Dubovis M, Rizk N. Case Rep Womens Health. 2020;27:e00208.
16. Batár I ve ark. Contraception. 2002;66(5):309–314.
17. Huang W ve ark. Front Cell Dev Biol. 2026;14:1790194.
18. Turok DK ve ark. N Engl J Med. 2021;384(4):335–344 · Gaio GS ve ark. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2024;305:153–158.
19. Cortessis VK ve ark. Obstet Gynecol. 2017;130(6):1226–1236.

20. CDC U.S. MEC 2024 · ACOG Practice Bulletin No. 186 (2017) ve Committee Statement No. 5 (2023) · AEMPS NI-PS 24/2019; BfArM 01783/18; FSRH CEU bildirisi (2021) · Eurogine 2026 ürün kataloğu, hasta bilgilendirme Rev. 09/2024, teknik föy Rev. 11/2020 · Bayer Nova-T 380 ürün bilgisi.

Hekime yönelik bilimsel bilgilendirme amaçlıdır; hasta tanıtım materyali değildir. Ürün-spesifik endikasyon, kontrendikasyon ve uygulama bilgisi için yürürlükteki kullanım talimatı (IFU) esastır. Görseller temsildir. · Eylül 2026